

CAPÍTULO 2.7

Arritmias en el Infarto

PERFIL EUNACOM 1.01.2.004

Dx: Específico • Tx: Inicial • Seg: Derivar

Introducción a las Arritmias en el Infarto Agudo al Miocardio (IAM)

Las arritmias son una complicación frecuente en el contexto del **Infarto agudo al miocardio (IAM)**. Si bien el manejo principal se centra en la revascularización del infarto, existen situaciones específicas donde el tratamiento de la arritmia es prioritario y puede ser vital para el paciente.

Arritmias en el Contexto del IAM

Manejo del Paro Cardiorrespiratorio (PCR)

Si un paciente con infarto entra en **Paro cardiorrespiratorio**, el manejo debe seguir el algoritmo de **RCP avanzado**.

Ritmo más frecuente: La **fibrilación ventricular (FV)** es la arritmia más común en pacientes que sufren un PCR intrahospitalario asociado a IAM. **Manejo:** Se debe identificar si el ritmo es desfibrilable o no y proceder según las guías de **RCP avanzado**.

Taquiarritmias Ventriculares

Taquicardia Ventricular (TV)

La **Taquicardia Ventricular (TV)** es una arritmia frecuente durante el IAM. Su manejo depende de la estabilidad hemodinámica del paciente.

TV con inestabilidad hemodinámica: Manejo: **Cardioversión eléctrica inmediata**. Esta es la situación más común. **TV con estabilidad hemodinámica:** Manejo: Fármacos antiarrítmicos específicos para TV, como la **amiodarona** o la **lidocaína**.

Arritmias de Reperusión

Las **arritmias de reperusión** son un fenómeno que ocurre después de restaurar el flujo sanguíneo a la arteria coronaria ocluida.

Definición: Son cualquier tipo de arritmia que aparece en los 30 minutos posteriores a la reperusión exitosa. **Reperusión se logra por:** **Angioplastia** coronaria. **Éxito de la Trombólisis** (evidenciado por disminución del dolor, descenso del segmento ST y mejoría hemodinámica). **Características:** Suelen ser **benignas**, independientemente de lo "feas" que puedan parecer en el electrocardiograma. Generalmente no requieren tratamiento específico. **Manejo:** La mayoría se manejan con **observación**. **Excepción:** La única arritmia de reperusión que sí requiere tratamiento es la **Taquicardia Ventricular sostenida** (que dura más de 30 segundos), la cual debe ser tratada con **lidocaína** o **amiodarona**.

Este resumen proporciona una guía concisa sobre las arritmias más relevantes en el contexto del infarto agudo al miocardio, su diagnóstico y manejo inicial, elementos clave para el examen EUNACOM.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 58 años con IAMSDST inferior, tras reperusión exitosa con angioplastia primaria, presenta ritmo regular de QRS ancho a 80 lpm sin compromiso hemodinámico. Trazado muestra complejos ventriculares idioventriculares."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

El ritmo idioventricular acelerado (RIVA) post-reperusión es un signo de reperusión exitosa, es benigno y autolimitado. NO requiere tratamiento. No confundir con TV sostenida. En cambio, la TV sostenida o FV en contexto de IAM requiere desfibrilación/cardioversión y Amiodarona EV.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La FV primaria es la principal causa de muerte prehospitalaria en el IAM
- El ritmo idioventricular acelerado es una arritmia de reperusión benigna que no requiere tratamiento
- El BAV en IAM inferior es generalmente transitorio y responde a atropina
- El BAV en IAM anterior es más grave, no responde a atropina y requiere marcapasos
- La bradicardia sinusal en IAM inferior se debe al reflejo de Bezold-Jarisch
- El bloqueo bifascicular nuevo en IAM anterior es indicación de marcapasos transitorio
- Las arritmias ventriculares tardías (después de 48h) tienen peor significado pronóstico

Extrasístoles Ventriculares (EV)

Las **Extrasístoles Ventriculares (EV)** aisladas son benignas en un paciente sano, pero en el contexto de un IAM, indican un riesgo aumentado de progresión a **Taquicardia Ventricular**.

Manejo: En el IAM, las EV se tratan con **antiarrítmicos**. **Fármacos:** **Beta-bloqueantes** y/o **amiodarona**.

Bradiarritmias

Las **bradiarritmias** en el IAM pueden manifestarse como bradicardia sinusal o bloqueos AV.

• **Causas:**

- Descarga vagal durante el infarto.
- *Isquemia del sistema éxito-conductor, afectando el **Nodo sinusal** o el **Nodo auriculoventricular**.*

• **Manejo:**

- 1. **Atropina** es el fármaco de elección.
- 2. Si no hay respuesta a la atropina, se considera la instalación de un **marcapaso externo transitorio**.

• **PERLA CLÍNICA EUNACOM**

*En el contexto de una bradiarritmia por IAM, lo más importante es la **angioplastia** y la revascularización inmediata del vaso culpable, ya que la isquemia es la causa subyacente.*

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ARRITMIAS EN EL INFARTO)**PREGUNTA 1**

Paciente con IAM inferior desarrolla BAV completo con FC de 45 lpm y escape de QRS angosto. PA 100/60. ¿Cuál es la conducta inicial?

- A)** Marcapasos transitorio inmediato
- B)** Atropina endovenosa
- C)** Isoproterenol
- D)** Amiodarona endovenosa
- E)** Cardioversión eléctrica

PREGUNTA 2

Paciente con IAM anterior extenso desarrolla súbitamente BAV completo con escape de QRS ancho a 30 lpm e hipotensión. ¿Cuál es la conducta?

- A)** Atropina y observar
- B)** Marcapasos transitorio urgente
- C)** Amiodarona endovenosa
- D)** Solo volumen endovenoso
- E)** Esperar porque es transitorio

PREGUNTA 3

Durante angioplastia primaria por IAM, al abrir la arteria culpable aparece un ritmo regular de QRS ancho a 80 lpm sin deterioro hemodinámico. ¿Qué es y qué hacer?

- A)** Taquicardia ventricular, cardioversión
- B)** Ritmo idioventricular acelerado, observar sin tratamiento
- C)** Fibrilación ventricular inminente, desfibrilar
- D)** Flutter ventricular, amiodarona
- E)** Bloqueo de rama nuevo, marcapasos

RESUMEN: ARRITMIAS EN EL INFARTO

Las arritmias son complicaciones frecuentes del infarto agudo de miocardio y pueden ser la causa de muerte en las primeras horas. La fibrilación ventricular primaria ocurre en las primeras 48 horas y es la principal causa de muerte prehospitalaria. Las arritmias de reperfusión, como el ritmo idioventricular acelerado, son generalmente benignas y no requieren tratamiento. Los trastornos de conducción son especialmente relevantes. El IAM inferior puede causar bloqueo AV por compromiso de la arteria del nodo AV (rama de la coronaria derecha), que es generalmente transitorio y responde a atropina. El IAM anterior puede causar bloqueo AV por necrosis extensa del sistema de conducción infranodal, que es más grave, no responde a atropina y frecuentemente requiere marcapasos transitorio o definitivo. La taquicardia y fibrilación ventricular post infarto tardías (después de 48 horas) tienen significado pronóstico diferente y pueden requerir desfibrilador implantable. La bradicardia sinusal es frecuente en el IAM inferior por reflejo de Bezold-Jarisch y generalmente responde a atropina. La taquicardia sinusal post infarto puede indicar insuficiencia cardíaca, dolor o ansiedad, y su persistencia se asocia a peor pronóstico.